Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Serra Talhada

R CABO JOAQUIM DA MATA, S/N, Forum Dr. Clodoaldo Bezerra de Souza e Silva, TANCREDO NEVES, SERRA TALHADA - PE - CEP: 56909-115 - F:(87) 39293586

Processo nº 0005989-77.2024.8.17.3370

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

S E N T E N Ç A

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** ajuizou a presente ação civil pública contra o **ESTADO DE PERNAMBUCO**, alegando, em suma, que:

> "[...].
>
> Em atendimento ao público em fevereiro de 2024, compareceu nesta Promotoria de Justiça, a Sra. Eliane Maria dos Santos Souza, 48 anos de idade, para relatar a necessidade de submeter-se a tratamento médico, face seu estado clínico, leia-se, diagnosticada no ano de 2014 com Leucemia Mieloide Crônica (CID 10: C92.1).
>
> Em razão disso, seguindo prescrição médica e o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, a requerente deu início, ainda no ano de 2014, ao tratamento por meio do uso de medicamento de 1ª linha - IMATINIBE 400 MG/DIA - para tratar sua doença hematológica. Cumpre pontuar que esse tratamento se deu até o início de 2022
>
> No entanto, devido à falta do medicamento Imatinibe na Farmácia do Estado de Pernambuco (Parecer Jurídico Hemope em anexo), o médico responsável pela paciente adotou em fevereiro de 2022, como providência para evitar a interrupção do tratamento, a substituição do medicamento IMATINIBE 400 MG/DIA pelo DASATINIBE (medicamento de 2ª Linha). Cumpre registrar que, conforme protocolo de diretriz terapêutica para o tratamento da Mielóide Aguda Crônica, a indicação do DASATINIBE somente ocorre quando constatada falha terapêutica ao tratamento de primeira linha, ou seja, ao IMATINIBE, o que não foi o caso.
>
> De acordo com as informações anexadas, ao utilizar o novo medicamento (DASATINIBE - 2ª linha), a paciente apresentou uma reação adversa grave ao DASATINIBE em agosto de 2023, a saber, Agudização da Função Renal e Síndrome Nefrótica - uma piora súbita e significativa da função dos rins, razão pela qual, restou contra indicado o DASATINIBE pelo risco de piora da função renal.
>
> Eleva frisar que a parte autora realiza acompanhamento regular no Hospital Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE. Em razão da resistência e contra indicação do remédio DASATINIBE, o médico que a acompanha, o hematologista do SUS, Dr. Diogo Felipe Leal Tine - CRM-PE: 24086, voltou a receitar à paciente o uso do medicamento IMATINIBE 400 MG - 40 CPS/MÊS - 40 CPS/MÊS (uso oral e contínuo), já que a paciente tolerou bem tal medicação por vários anos. (Prescrição de medicação em anexo)
>
> No entanto, tanto a Secretaria de Saúde como a própria farmácia do HEMOPE informaram que o SUS não autorizava referida troca. Isso porque, segundo o HEMOPE, a mudança (na verdade o retorno) do tratamento de 2ª linha para um de 1ª linha, a luz do Ministério da Saúde, se revela como um tratamento de 3ª linha e, como tal, não seria de sua competência e sim do próprio Ministério da Saúde.
>
> Ainda segundo o Hemope, a terceira linha que se referiu em sua resposta diz respeito à mudança (retorno) do tratamento de 2ª linha para o de 1ª, cabendo nesses casos, aos hospitais habilitados como de Alta Complexidade a definição do tratamento mais adequado. Em outras palavras, a indicação da mudança do tratamento de 2ª linha para o de 1ª linha não seria da competência do HEMOPE e sim das Unidades e Atendimento Oncológico, por meio do Ministério da Saúde.
>
> Nesse sentido, segue transcrição do Protocolo Clínico da Diretriz Terapêutica voltado aos casos de Leucemia Mielóide Crônica:
>
> [...].
>
> Contudo, deve-se consignar que a mudança do tratamento de 2ª linha para o de 1ª linha dispensa análise técnica, na medida em que a alteração do medicamento de 1ª linha para o de 2ª linha se deu em razão da falta do medicamento Imatinibe na Farmácia do Estado de Pernambuco, conforme laudo médico do próprio HEMOPE, sendo que, para não comprometer o tratamento da paciente, foi indicado um fármaco de 2ª linha. A paciente fazia seu tratamento normal,

sem complicações, nem efeitos colaterais, seguindo o protocolo de diretriz terapêutica, com a utilização de medicamento de 1ª linha. A aceitação ao medicamento de 1ª linha foi tão exitosa, que o médico que a acompanha, receitou-o novamente.

A situação é diferente quando a requerente utiliza o medicamento DASATINIBE. Os exames e relatórios médicos anexados detalham o quadro clínico da Sra. Eliane, descrevendo os efeitos colaterais como Síndrome Nefrótica (CID N04.9) e Doença Renal em estádio final (N18.0).

Desde o diagnóstico de leucemia, o uso do medicamento IMATINIBE resultou na remissão da doença hematológica. Contudo, ao realizar a troca por DASATINIBE em agosto de 2023, houve uma piora na função renal como efeito colateral. Após iniciar o uso de Dasatinibe, a paciente apresentou reações adversas, sendo encaminhada ao setor de nefrologia devido ao surgimento de edema em MMII (inchaço das pernas causado pela retenção de líquido nos tecidos) e abdome, associado a proteinúria inicialmente nefrótica.

Registra-se que somente quando realizou a suspensão de Dasatinibe apresentou melhora, conforme evidencia Laudo Médico emitido pelo médico. No entanto, os efeitos colaterais persistiram com níveis subnefróticos de hematúria (sangue na urina), associado a diarreia aquosa (3-5 episódios/dia), evidenciando a inadequação do tratamento com Dasatinibe para a paciente.

A piora na função renal foi tão significativa que, em maio, a paciente foi internada no Hospital das Clínicas em Pernambuco, vinculado ao SUS. O resumo da alta hospitalar, em anexo, evidencia sinais de nefropatia parenquimatosa crônica, podendo ocasionar a perda progressiva da função renal, além do seu quadro de Leucemia Mieloide se tornar Aguda, evoluindo para o estado mais agressivo da doença.

Os exames de hemograma completo anexados da Sra. Eliane, em especial o de Ureia, que avalia a função renal, revelam o aumento elevado dessa substância, produzida pelo fígado e excretada pelos rins na forma de urina, o que evidencia a piora da função renal.

Fato é que a parte autora segue sem ter a sua demanda atendida, convivendo com os desconfortos gerados por sua enfermidade e com o risco provável de agravamento de seu quadro de saúde para uma Leucemia Mieloide Aguda.

[...].”

Com a petição inicial vieram documentos.

Proferiu-se decisão concedendo a tutela de urgência (ID 190587228).

O ESTADO DE PERNAMBUCO informou a disponibilidade do medicamento (ID 191739517) e apresentou contestação (ID 191739517), oportunidade em que defendeu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, em síntese, requereu a improcedência do pedido.

O ente público requerido apresentou também Embargos de Declaração (ID 193384435).

É o breve relato. **Decido**.

Cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento abreviado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois desnecessária a dilação probatória para a oferta da prestação jurisdicional.

Por oportuno, cabe esclarecer que *“Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC”* (Enunciado n° 27 da I Jornada de Direito Processual Civil realizado STJ/CJF).

Antes de adentrar no mérito do caso em debate, passo à análise da preliminar suscitada.

REJEITO a preliminar de incompetência, pois, em sede de Embargos de Declaração no RE 1.366.243, o STF decidiu acolher os embargos “[...]. **a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1**, referente à Competência, a seguinte redação”:

“[...].

1) Para fins de **fixação de competência**, as demandas relativas a medicamentos **não incorporados** na política pública do SUS **e medicamentos oncológicos**, ambos com registro na ANVISA, **tramitarão perante a Justiça Federal**, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, **quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo**, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for **igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos**, na forma do art. 292 do CPC; e

[...].” (g.n.)

Desse modo, **não basta** ser medicamento oncológico para que seja definida a competência da Justiça Federal, sendo preciso, ainda, que o valor do tratamento **anual** do fármaco ou do princípio ativo seja **igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos**, situação que não ficou demonstrada.

Quanto aos embargos de declaração, hei por bem **REJEITÁ-LOS**, pois ausentes os requisitos legais. A pretensão do embargante é de combater o mérito da decisão, e, com isso, deveria manejar o recurso adequado.

Superadas essas questões, passo ao exame do mérito.

Sem maiores delongas, esclareço, desde logo, que o pedido formulado na exordial deve ser julgado **procedente**.

Explico.

A CRFB, em seu art. 6º, estabelece que:

"São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".

Por sua vez, o art. 196 da Carta Magna define que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Conforme se depreende dos preceitos constitucionais suso transcritos, compete ao Poder Público garantir e assegurar o direito à saúde, que é indissociável do direito à vida, prerrogativa constitucional com caráter de direito fundamental, que não pode ser preterido por questões burocráticas, políticas, econômicas ou orçamentárias.

Neste passo, já afirmou o Ministro Marco Aurélio que *"o Estado deve assumir as funções que lhe são próprias, sendo certo, ainda, que problemas orçamentários não podem obstaculizar o implemento do que previsto constitucionalmente"*[1] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%

No expressivo dizer de José Afonso da Silva, *"o sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no pólo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, com direção única em cada esfera de governo, do atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, e da participação da comunidade, que confirma seu caráter de direito social pessoal, de um lado, e de direito social coletivo, de outro"*[2] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%

Nessa esteira de raciocínio, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal: *"O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconseqüente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado"*[3] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%

Conclui-se, pois, que a garantia constitucional e/ou direito à saúde e os meios necessários para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana não significam tão somente um “sonho” do legislador constituinte embebido em devaneio altruísta.

A moderna hermenêutica constitucional aponta para a máxima eficácia das normas, mesmo em se tratando de normas programáticas, sendo que no caso depara-se com normas imediatamente preceptivas, dado o grau imediato de comando e eficácia.

Assim, seja com base nos preceptivos constitucionais invocados, de eficácia não programática, mas auto-executáveis, seja com base na legislação infraconstitucional, o direito invocado está garantido na *Lex Mater*, e deve ser efetivado mediante a obrigação dos Municípios e do Estado em arcar com despesas referentes ao fornecimento de medicamentos e insumos, devidamente prescritos, aos cidadãos sujeitos a tratamento médico específico e, por conseguinte, garantirem o direito à vida.

Nesse passo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, especialmente os mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso,

fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios necessários para garantir-lhes melhor qualidade de vida, diminuindo os sofrimentos de que padecem.

Como se pode notar, a Sr.ª ELAINE MARIA DOS SANTOS SOUZA sofre de Leucemia Mieloide Crônica (CID 10: C92.1), e, **desde o ano de 2014**, fazia tratamento com "IMATINIBE", medicação de 1ª linha para a enfermidade.

Contudo, em fevereiro de 2022, em virtude do **desabastecimento** do "IMATINIBE", deu-se seguimento ao tratamento com a mediação de 2ª linha, no caso "DESATINIBE".

Ocorre que a Sr.ª ELAINE MARIA DOS SANTOS SOUZA apresentou reação adversa grave ao medicamento "DESATINIBE", tendo o médico responsável contraindicado o referido fármaco e indicado o **retorno** do tratamento com "IMATINIBE" (ID 190577168).

Desse modo, **não há controvérsia a respeito da necessidade de utilização do medicamento**, pois, como mencionado, a Sr.ª ELAINE MARIA DOS SANTOS SOUZA somente deixou de utilizar "IMATINIBE" por desabastecimento momentâneo do medicamento.

Em virtude dessa situação, mostra-se **desnecessário consultar o NATJUS**.

A negativa do ESTADO DE PERNAMBUCO no sentido de que a proposta de retorno à utilização do "IMATINIBE" seria a adoção de uma 3ª linha de tratamento (ID 190577165 – Pag. 4) sequer faz sentido e contraria frontalmente tudo o que foi detidamente explicado pelo médico do HEMOPE.

Ora, nada mais natural que, uma vez normalizado o estoque do medicamento "IMATINIBE", retorne a Sr.ª ELAINE MARIA DOS SANTOS SOUZA ao tratamento com esse fármaco que, repita-se, trata-se da 1ª linha de tratamento. Não bastasse isso, a paciente apresentou reação grave ao medicamento "DESATINIBE", tendo resultado **sério risco de agravamento de sua saúde**.

Consigno, por fim, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante art. 489, §1º, IV, do CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça[4] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%AAncia decidiu que *"[...]. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...]"*.

ANTE O EXPOSTO, **ratifico** a decisão de ID 190587228, e, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para **JULGAR PROCEDENTE** o pedido formulado na petição inicial para **CONDENAR** o ESTADO DE PERNAMBUCO a fornecer à Sr.ª ELAINE MARIA DOS SANTOS SOUZA, imediatamente (petição de ID 191739517), caso já não esteja fornecendo, o medicamento "IMATINIBE", na forma e tempo receitado.

Em conformidade com o item "3.2." da tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral do STF e Súmula Vinculante n° 60, estabeleço que o **valor de venda** do medicamento deverá ser limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), **ou** valor já praticado pelo ente em compra pública, **aquele que seja identificado como menor valor**, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Em **nenhuma hipótese**, poderá haver pagamento judicial em **valor superior ao teto do PMVG**, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

Em conformidade com o art. 7º, *caput*, da Recomendação nº 146/2023 do CNJ, *"A forma de aquisição, o local e o procedimento de entrega dos produtos e medicamentos serão definidos pelo ente público responsável pelo cumprimento*".

Note-se que, *"Na hipótese excepcional de entrega do medicamento, do produto ou da tecnologia na residência da parte autora, caberá a ela informar o respectivo recebimento no processo judicial"* (art. 7º, § 2º, da Recomendação nº 146/2023 do CNJ).

Nos moldes do art. 10, § 2º, da Recomendação nº 146/2023 do CNJ, *"O ente público responsável que informar a impossibilidade do cumprimento in natura depositará o valor, ou pleiteará que seja feito o bloqueio em suas próprias contas, informando os dados bancários da conta a ser bloqueada"*.

Nos termos do Enunciado nº 2, da 1ª Jornada de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça e art. 7º, § 1º, e art. 14, todos da Recomendação nº 146/2023 do CNJ , **DEVERÁ** a Sr.ª ELAINE MARIA DOS SANTOS SOUZA apresentar, **a cada 03 (três) meses**, a contar da data de hoje, relatório/atestado médico atualizado indicado a necessidade e a indispensabilidade do tratamento, **diretamente ao ente responsável pelo cumprimento ou ao ente responsável pela dispensação**, sob pena de perda de eficácia da medida, que será, eventualmente, declarada por este Juízo.

Configura abandono de tratamento a não retirada injustificada do medicamento e outros produtos por mais de 3 (três) meses consecutivos, facultando-se ao demandado a suspensão das respectivas aquisições, devendo, ainda, informar ao juízo o respectivo abandono, a fim de avaliar a possibilidade de suspensão ou extinção do processo judicial, sem prejuízo da determinação de reparação ao ente público (art. 16 da Recomendação nº 146/2023 do CNJ).

Isento o Estado de Pernambuco das custas processuais. Sem condenação em honorários, pois incabíveis em ação movida pelo Ministério Público.

Na forma do art. 496 do CPC, Súmula n° 490[5] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%AAncia do STJ e REsp 1101727/PR[6] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%AAncia (recurso repetitivo), tratando-se de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, aguarde-se prazo para interposição de recurso voluntário e **REMETAM-SE** os autos em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Em sendo interposto recurso de **APELAÇÃO**, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, **INTIME-SE** o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do CPC), **INTIME-SE** a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso sejam apresentadas contrarrazões, em sendo suscitadas preliminares, **INTIME-SE** o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca das referidas questões.

Após o prazo, com ou sem resposta, *ex vi* do disposto no § 3º do art. 1.010 do CPC, **REMETAM-SE** os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, independentemente do juízo de admissibilidade.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado. Após, arquive-se.

Serra Talhada/PE, data conforme registro da assinatura eletrônica.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres
Juiz de Direito

---

[1] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%AAncia
Voto condutor nos autos do RE 195.192-3/RS - Segunda Turma do STF - julgado em 22/02/00.

[2] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%AAncia
Curso de Direito Constitucional Positivo, 11. ed. - São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 762.

[3] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%AAncia
STF, 2ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 271.286/RS, Relator Ministro Celso de Mello, j. 12.09.2000, DJ 24.11.2000, p. 101.

[4] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%AAncia
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

[5] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%AAncia

"A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"

[6] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/02%20-%20Fevereiro/070225/Senten%C3%A7a.PRO.ACP.sa%C3%BAde.IMATINIBE.oncol%C3%B3gico.compet%C3%AAncia

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. 1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil." (STJ, REsp 1101727/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJe 03/12/2009)

Assinado eletronicamente por: DIOGENES PORTELA SABOIA SOARES TORRES
07/02/2025 10:17:23
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 194655961

25020710172371300000189730890

IMPRIMIR GERAR PDF